



Ministère de la Santé et de la Lutte
contre le Sida



Programme National de Santé
Infantile et de la Survie de l'Enfant

LES 12 PRATIQUES FAMILIALES ESSENTIELLES (PFE) POUR LA SURVIE ET LE DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT

MANUEL DU SUPERVISEUR DE L'AGENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE

AOÛT 2012



REMERCIEMENTS

Le Programme National de Santé Infantile et de la Survie de l'Enfant (PNSI/SE) remercie toutes les institutions et tous les partenaires qui ont contribué à l'élaboration, à la révision et à la validation de ce document.

- Pour le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA:

- DSCMP (Direction de la Santé Communautaire et de la Médecine de Proximité)
- DFR (Direction de la Formation et de la Recherche)
- DIRE (Direction de l'Information de la Planification et de l'Evaluation)
- INSP (Institut National de Santé Publique)
- PEV (Programme Elargie de Vaccination)
- PNLCé (Programme National de lutte contre la Cécité)
- PNLP (Programme National de Lutte contre le Paludisme)
- PNN (Programme National de Nutrition)
- PNPEC (Programme National de Prise En Charge des Personnes vivant avec le VIH)
- PNSSU (Programme National de Santé Scolaire et Universitaire)
- PNEVG/EA (Programme National d'Eradication du Ver de Guinée/ Eau et Assainissement)
- PNSR/PF (Programme National de Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale)
- Projet SASDE (Stratégie Accélérée pour la Survie et le Développement de l'Enfant)
- Direction Régionale de la Santé de l'Agnéby
- Districts sanitaires de Man, Kouibly, Bouaké-Ouest, Dabakala, Odienné, Agboville

- Pour les Partenaires :

- OMS
- UNICEF
- Section C4D du Bureau régional UNICEF Dakar
- HKI
- PATH/IYCN
- EGPAF

- Pour les ONG :

- ASAPSU
- AIP
- ARK
- IBFAN-CI
- ACONDA

SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

AIP	Association Ivoirienne pour le Progrès
ARK	Animation Rurale de Korhogo
ARV	Antirétroviraux
ASC	Agent de Santé Communautaire
ASAPSU	Association de Soutien à l'Auto Promotion Sanitaire Urbaine
BCG	Bacille Calmette et Guérin
CGC	Communication pour le Changement de Comportement
CPN	Consultation Prénatale
CPN+	Consultation Prénatale Recentrée
CS	Centre de Santé
Hib	Haemophilus influenzae b
HKI	Helen Keller International
IBFAN-CI	International Baby Food Action Network Côte d'Ivoire
IRA	Infection Respiratoire Aiguë
MILDA	Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action
MSLS	Min/stère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA
MUAC	Mètre ruban pour mesure du périmètre brachial
NNE	Nouveau-né
OEV	Orphelin et Enfant Vulnérable du fait du VIH/sida
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
QMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PATH/IYCN	Program for Appropriate Technology for Health/Infants Young Child Nutrition Project
PCIMNE	Prise en Charge Intégrée des Maladies du Nouveau-né et de l'Enfant
PCIMNE-c	Prise en Charge Intégrée des Maladies du Nouveau-né et de l'Enfant au niveau Communautaire
PEV	Programme Elargi de Vaccination
PFE	Pratique Familiale Essentielle
POLIO	Poliomyélite
SASDE	Stratégie Accélérée pour la Survie et le Développement de l'Enfant
SIDA	Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise
SMN	Santé Maternelle et Néonatale "
SSE	Stratégie de Survie de l'Enfant
SRO	Sel /Solution de Réhydratation par voie Orale
TME	Transmission Mère Enfant
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
	Virus de l'Immunodéficience Humaine
VIH	Vitamine A
Vit. A	Programme Elargi de Vaccination
VPO	Vaccin Polio Oral

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
GENERALITES.....	5
PFE N° 1: Relative à la prise en charge du nouveau-né.....	7
PFE N° 2: Relative à l'Allaitement Maternel Exclusif	9
PFE N° 3: Relative à l'alimentation de complément	12
PFE N° 4: Relative à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage de l'enfant	14
PFE N° 5: Relative à la consommation du sel iodé dans le ménage	17
PFE N° 6: Relative à la vaccination.....	20
PFE N° 7: Relative au lavage des mains.....	23
PFE N° 8: Relative à l'utilisation de la MILDA	24
PFE N° 9: Relative à la prise en charge des cas de maladies à domicile.....	26
Prise en charge de la diarrhée	26
Prise en charge de la fièvre/paludisme	29
Prise en charge de la toux et des difficultés respiratoires	31
PFE N° 10: Relative à la reconnaissance des signes de danger chez l'enfant.....	33
PFE N° 11: Relative à la Consultation Prénatale et à l'accouchement assisté par un personnel qualifié	35
PFE N° 12: Relative à la Consultation post-natale.....	38
ANNEXES SUR LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION	39
ANNEXE1 : La visite à domicile (VAD)	40
ANNEXE2 : L'animation de Groupe	42
ANNEXE 3 : Utilisation de la boîte à images.....	44

INTRODUCTION

La Stratégie de Survie de l'Enfant (SSE) pour les pays en développement a été initiée par les Partenaires au développement (QMS, UNICEF, Banque Mondiale) pour l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Cette stratégie peu coûteuse, à haut impact sur la mortalité infanto-juvénile a fait ses preuves là où elle a été déjà mise en œuvre. Elle implique une participation active de la communauté dans la prévention et la prise en charge des cas à travers les pratiques familiales et communautaires dites Pratiques Familiales Essentielles (PFE).

A l'instar de certains pays (Sénégal, Mali, Bénin ...), le gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers le Ministère en charge de la Santé et avec l'appui de ses Partenaires, a adopté cette stratégie dont la mise en œuvre de façon intégrée se fera au niveau opérationnel.

Cette stratégie vise à promouvoir la croissance et le développement de l'enfant, à prévenir la maladie et à y faire face convenablement quand elle se présente.

Les cinq paquets d'interventions essentielles de cette stratégie sont:

- le Programme Elargi de Vaccination plus (PEV+);
- la Prise en Charge Intégrée des Maladies du Nouveau-né et de l'Enfant plus (PCIMNE +);
- la Santé Maternelle et Néonatale plus (SMN+);
- la Prévention de la Transmission Mère -Enfant du VIH/SIDA plus (PTME+) et
- l'Eau, hygiène et assainissement.

La mise en œuvre de ces activités permettra à notre pays de réduire de manière significative le taux de mortalité encore très élevé des enfants de moins de 5 ans (108 ‰-EIS-CI III 2011-2012). En effet, les causes de ces décès sont dues à des affections courantes (affections néonatales, paludisme, diarrhée, pneumonie, rougeole et infections à VIH), lesquelles peuvent être prévenues ou traitées à moindre coût. La malnutrition et le VIH/sida constituent des facteurs aggravant de ces pathologies.

La promotion des PFE ne peut se faire qu'à travers une stratégie de communication pour le changement de comportement et la disponibilité des services au sein de la communauté.

Les Agents de Santé Communautaires (ASC) constituent l'interface entre la communauté et les services de santé. Pour la réussite de leur mission, ils ont besoin d'acquérir des connaissances et des compétences indispensables. Ces aptitudes ne sont acquises que par la formation d'où l'importance d'élaborer un manuel de formation et des outils de gestion à leur intention.

GENERALITES

I- LA PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DU NOUVEAU-NE ET DE L'ENFANT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE (PCIMNE-c)

La PCIMNE-C vise à améliorer l'état de santé des enfants par la promotion de bonnes pratiques familiales et communautaires.

La réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans nécessite plus que la disponibilité de services de santé adéquats avec un personnel bien formé. Les familles étant les premiers responsables de leurs enfants, la réussite des actions visant à réduire le nombre de décès de ces enfants nécessite un partenariat entre les agents de santé et les familles, avec l'appui de leurs communautés.

En effet, les agents de santé s'assurent que les familles peuvent prodiguer à leurs enfants les soins appropriés à domicile en vue de soutenir leur croissance et leur développement. Les familles aussi doivent pouvoir réagir convenablement lorsque leurs enfants tombent malades en recherchant une assistance appropriée et opportune et en administrant des traitements recommandés.

Il est important que la PCIMNE-c implique les familles et les communautés dans la prise en charge de la santé des enfants et les assiste dans l'évaluation, l'analyse et la prise de mesures correctrices pour résoudre leurs problèmes et ceux des enfants. Elle assure aussi la promotion de la participation des parents, des autres prestataires de soins primaires (ASC) et des communautés pour pérenniser les nouvelles pratiques qui supportent les changements qu'ils ont choisis d'introduire dans la santé des enfants. L'implication des communautés, ainsi que le renforcement de leurs capacités sont essentiels dans la mise en œuvre de la PCIMNE-C qui vise à améliorer les pratiques familiales essentielles et communautaires. Ces pratiques au nombre de

12 sont regroupées en quatre points à savoir: la promotion de la croissance et du développement, la prévention des maladies, la prise en charge des cas à domicile et la recherche des soins et pratiques hors du domicile.

II- LES PRATIQUES FAMILIALES ESSENTIELLES (PFE)

De façon générale 18 PFE existent, la Côte d'Ivoire en a retenu 12 pour être promues au sein des familles et des communautés. Ces PFE sont réparties en 4 groupes :

• Groupe 1 ; Promotion de la croissance et du développement du nouveau-né et de l'enfant

PFE 1 : La mère, le père ou la personne à charge de l'enfant prend en charge le nouveau-né

PFE2 : La mère allaite exclusivement le nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois

PFE 3 : La mère nourrit l'enfant à partir de l'âge de 6 mois avec les aliments de complément équilibrés, fraîchement préparés de façon hygiénique tout en continuant à l'allaiter jusqu'à 24 mois

PFE 4 : Tous les 6 mois, la mère, le père ou la personne à charge de l'enfant fait supplémenter le nourrisson et l'enfant de 6 à 59 mois en Vitamine A et en plus, le fait déparasiter à partir de 12 mois

PFE 5 : Les ménages consomment tous les jours du sel iodé dans leur alimentation

- **Groupe 2 : Prévention des maladies**

PFE 6 : La mère, le père ou la personne à charge de l'enfant fait vacciner complètement l'enfant^ avant l'âge de 1 an

PFE 7 : La mère, le père ou la personne à charge de l'enfant lave ses mains avec de l'eau propre et du savon et observe les bonnes pratiques d'hygiène du milieu : avant de préparer les' repas des enfants, avant de nourrir les enfants, après la défécation, après avoir éliminé, correctement les selles des enfants.

PFE 8 : La femme enceinte et les enfants de 0 à 5 ans dorment toutes les nuits sous Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action (MILDA)

- **Groupe 3 : Prise en charge des cas à domicile**

PFE 9 : La mère, le père ou la personne à charge de l'enfant donne à l'enfant le traitement adéquat à domicile :

- de la diarrhée,
- de la fièvre et du paludisme,
- des Infections Respiratoires Aiguës (IRA).

- **Groupe 4 : Recherche des soins au centre de santé**

PFE 10: La mère, le père ou la personne à charge de l'enfant reconnaît les signes de danger/gravité afin de l'emmener à temps chez le prestataire qualifié au Centre de Santé pour recevoir les soins appropriés

PFE 11: La femme enceinte se fait suivre en consultation prénatale recentrée (CPNr+) et accouche sous la surveillance d'un personnel qualifié

PFE 12: La mère et l'enfant se font suivre après l'accouchement par un personnel qualifié

PFE N° 1: RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DU NOUVEAU-NE

La mère, le père ou la personne à charge de l'enfant prend en charge le nouveau-né (0 à 28 jours)

Pourquoi déclarer le nouveau-né?

Un enfant doit être déclaré à l'état civil car c'est son droit de citoyen. La déclaration à l'état civil lui donne droit à une identité, à une nationalité, à l'éducation, à des soins de santé. Une fois majeur, cela lui permettra d'obtenir un certificat de nationalité, un emploi stable, d'ouvrir un compte en banque, de voter, hériter de ses parents, etc.

Quand faut-il déclarer son enfant à l'état civil ?

Tout enfant né en Côte d'Ivoire doit être déclaré dans les trois (03) mois qui suivent l'accouchement, que cet accouchement ait eu lieu dans un centre de santé ou à domicile.

Quels sont les signes de danger et d'affections néonatales?

❖ Signes de danger :

- Une convulsion (traduire dans la langue locale)
- L'incapacité de téter (ou refus de téter)
- Les troubles du tonus (l'enfant devient mou ou raide)
- L'hyperthermie ou hypothermie (corps chaud ou trop froid)
- La léthargie ou inconscience (enfant anormalement somnolent)
- Le tirage sous costal marqué (la respiration ne descend pas ou respiration du margouillat)
- Une respiration rapide (60 respirations par minute ou plus) ou lente
- Un geignement (bruit rauque entendu à l'expiration)
- Une cyanose (le bébé devient foncé).

❖ Signes d'infections néonatales :

- l'ictère (coloration jaune des yeux, de la paume et de la plante des pieds)
- L'anémie
- L'hyperthermie ou hypothermie (corps chaud ou trop froid)
- La distension (ballonnement) abdominale
- Les pustules cutanées (boutons avec liquide) nombreuses et importantes
- La rougeur ombilicale s'étendant à la zone péri-ombilicale ou pus s'écoulant de l'ombilic
- La fontanelle bombée.



Comment suivre un enfant né de mère séropositive ?

Pour suivre un enfant né de mère séropositive l'ASC doit :

- S'assurer que le nouveau-né a reçu un Kit Bébé pour la prophylaxie TME qui doit être pris dans les 72 heures (03 jours) après l'accouchement.
- Veiller au suivi du traitement prophylactique TME prescrit au centre de santé
- Veiller au respect du choix de l'alimentation du nouveau-né et l'accompagner dans ce choix {Allaitement maternel exclusif ou alimentation de remplacement}.
- Veiller au respect des dates de suivi clinique au centre de santé
- Encourager la mère à faire le dépistage précoce dès 6 semaines

Ce que l'ASC doit faire pour tous les cas

- *Encourager le père ou la mère à déclarer le nouveau-né à l'état civil ;*
- *Enregistrer le nouveau-né dans le registre de l'ASC ;*
- *Orienter le nouveau-né vers un centre de santé en cas de signes de danger et de signes liés aux affections néonatales pour recevoir des soins appropriés ;*
- *Démontrer comment garder le nouveau-né au chaud*
- *Faire le suivi des soins du nouveau-né notamment le nouveau-né de faible poids de naissance et le nouveau-né à haut risque (Nouveau-né né de mère séropositive au VIH) ;*
- *Prendre et lire la température du nouveau-né et la noter dans le carnet de santé de l'enfant ;*
- *Faire le suivi des soins des yeux, du cordon ombilical et de la peau du nouveau-né ;*
- *Vérifier la vaccination chez le nouveau-né (BCG et polio 0) et encourager la mère à retourner au centre de santé pour faire vacciner le nouveau-né ;*
- *Soutenir les pratiques optimales de l'allaitement dans la communauté et expliquer aux concernés les avantages de l'allaitement exclusif;*
Recenser les OEV et les orienter au centre de santé.

PFE N° 2: RELATIVE A L'ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF

**La mère allaite exclusivement le nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois.
(A la demande, de jour comme de nuit, au moins 8 fois par 24 heures)**

Définitions

- Allaitement maternel: Pratique qui consiste à nourrir le bébé au sein (lait maternel)
- Allaitement maternel exclusif: Donner uniquement du lait maternel à un bébé dès sa naissance jusqu'à l'âge de six mois (à l'exception des médicaments prescrits).
 - Pas d'aliments "pré-allaitement"
 - Pas d'aliments solides
 - Pas d'aliments semi-solides v. .
 - Pas de liquides
 - Pas d'eau

Quand commencer l'allaitement?

- Immédiatement après la naissance
- Le premier lait jaune (colostrum) = médicament naturel contient vitamine A. Il protège la santé du nourrisson.
- L'état de maladie de la mère ou de l'enfant n'empêche pas l'allaitement

Avantages de l'AME

1. Avantages pour le bébé

- Aliment complet
- Contient des éléments nutritifs idéaux (eau, vitamines, etc.)
- Facile à digérer; Bien assimilé
- Protège contre les infections, les diarrhées
- Sécurité émotionnellement, rend intelligent.

2. Avantages de l'AME pour la mère

- Relation intime, affective entre la mère et le bébé Permet d'éviter une nouvelle grossesse
- Moins coûteux que l'alimentation artificielle ou de remplacement Réduit le risque de cancer des ovaires et du sein

3. Avantages pour le père

- Moins de dépenses en frais médicaux
- Epanouissement de la famille

4. Avantages pour la famille et la communauté

- Épargne l'achat des substituts du lait maternel
- Réduit les dépenses de soins de santé
- Préserve les ressources naturelles
- Réduit la contamination
- La famille économise pour d'autres besoins
- Moins de dépenses en combustible et en eau
- Moins de maladies, moins de médicaments à acheter
- Toujours prêt à être consommé, ne nécessite pas de préparation.

Comment donner à téter ?

Position de la mère

Mère assise :

- le dos est droit
- la mère amène l'enfant vers son sein

Mère couchée :

- la mère est allongée sur le côté (sur le dos si jumeaux)
- l'enfant lui fait face

Bonne position de l'enfant au sein

Les quatre points-clés sont :

- La tête et le corps sont droits ;
- Le visage est face au sein et le nez face au bout du sein ;
- Le corps est près de celui de la mère ;
- Tout le corps est soutenu par la mère (s'il s'agit d'un nouveau-né).

Bonne prise du sein

Les quatre points-clés sont :

- La bouche est grande ouverte
- Le menton touche le sein
- La lèvre inférieure est repliée vers le bas
- la bouche de l'enfant couvre une grande partie de la zone noire du sein (aréole).

Tétée efficace

- Les joues sont bien rondes et remplies de lait
- L'enfant tète lentement et profondément en s'arrêtant de temps en temps
- On entend et / ou on voit l'enfant avaler
- Bien vider le premier sein avant de donner le second.

Qu'est-ce qu'une femme allaitante peut manger ?

Une femme qui allaite, doit avoir une alimentation équilibrée et prendre un repas supplémentaire (en plus des repas quotidiens). Son alimentation quotidienne doit être composée des quatre groupes d'aliments ci-dessous cités :

- **Aliments énergétiques de base** : Riz, blé, maïs, sorgho, mil, fonio, pomme de terre, igname, patate douce, manioc, banane plantain
- **Aliments énergétiques de complément** : Huile, beurre, sucre, arachide, avocat
- **Aliments de construction** : poisson, viande, œuf, poulet, chenille, crevette, grenouille, haricot, lentille, graine de courge, soja (en graine)
- **Aliments de protection : Légumes** : tomates, gombos, feuilles vertes, amarante (Kprala ou Clouala), épinard, feuilles de manioc, feuilles de patates, feuilles d'aubergine. Fruits : mangue, papaye, citron, banane douce, orange

A RETENIR

Allaiter exclusivement un nourrisson veut dire que sa mère ne lui donne que son lait, sans eau, ni jus de fruit, ni tisane (sauf les médicaments prescrits).

- Recenser les femmes qui ont accouché.
- Rendre visite aux femmes accouchées et à leurs bébés.
- Discuter de l'allaitement avec la mère : conseiller la mère sur les bonnes pratiques de l'allaitement.
- Observer la mise au sein.
- Corriger la mise au sein si nécessaire.

- Programmer avec la mère une autre visite

Bonne prise du sein



Mauvaise prise du sein



PFE N° 3: RELATIVE A L'ALIMENTATION DE COMPLEMENT :

La mère nourrit l'enfant à partir de l'âge de 6 mois avec les aliments de complément fraîchement préparés et équilibrés tout en continuant à l'allaiter jusqu'à 24 mois.

Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée ?

Une alimentation est équilibrée lorsque les aliments des trois groupes sont utilisés ensemble dans des quantités adéquates pour constituer le repas.

Comment constituer une alimentation équilibrée?

- Le lait maternel est le seul aliment complet.
- Une alimentation est dite équilibrée, lorsque le repas de l'enfant est constitué d'ingrédients des 3 groupes d'aliments précités. Ces aliments locaux peuvent être utilisés en fonction de la nature de leurs apports
- Il s'agit de choisir un ingrédient de chaque groupe pour constituer ensemble une alimentation équilibrée pour l'enfant selon la disponibilité dans la communauté.

Comment constituer une alimentation équilibrée?

1. Aliments de force (glucides, lipides)

Constitués par les **Aliments énergétiques de base** et les **Aliments énergétiques de complément**

Aliments énergétiques de base

- Céréales: riz, blé, sorgho, mil, fonio
- Tubercules: pomme de terre, igname, manioc, patate douce
- Banane plantain

Aliments énergétiques de complément

- Huile, beurre, sucre, arachide, avocat

2. Aliments de construction (protides)

Constitués par :

- **Origine animale** : poisson, viande, œuf, poulet, chenilles, crevettes, grenouilles etc.
- **Origine végétale** : haricot, lentilles, graine de courge, soja (en graine)

3. Aliments de protection (vitamines et sels minéraux).

Constitués par :

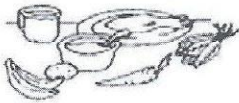
- **Légumes** : tomates, gombos, feuilles vertes, amarante (Kprala ou clouala), épinard, feuilles de manioc...

Fruits : mangue, papayes, citrons, banane douce, orange...

Comment assurer à l'enfant une alimentation saine et propre ?

- Choisir les aliments frais
- Laver les mains à l'eau propre et au savon avant la préparation du repas
- Laver les ustensiles de cuisine à l'eau propre et au savon et les sécher sur une claie, hors de portée des enfants et des animaux
- Donner au nourrisson uniquement des aliments qui viennent d'être épluchés, lavés ou cuisinés
- Couvrir les aliments pour les protéger contre les poussières, les mouches et autres insectes.

CALENDRIER NUTRITIONNEL

De la naissance à 6 mois	De 6 mois à 9 mois	De 9 mois à 2 ans	2 ans et plus
 Commencer l'allaitement dans l'heure qui suit l'accouchement. Rien donner d'autre en dehors du sein de la mère Allaiter aussi souvent que l'enfant réclame, jour et nuit, au moins 8 fois en 24 heures	 Continuer à allaiter à la demande nuit et jour, au moins 8 fois par 24 heures En plus : • donner 2 bouillies épaisses de céréales enrichies au lait, à l'huile, à l'œuf, à la pâte d'arachide ou au beurre de karité ou bien d'autres aliments tels que l'igname sous forme de pâte enrichie à l'huile ou au beurre de karité. • donner 1 repas familial sans épice • donner 2 goûters : yaourt, œuf dur, galette, pain garni, fruit de saison, etc. 	 Continuer à allaiter à la demande nuit et jour • Donner 1 bouillie épaisse de céréales enrichies soit au lait, à l'huile, à l'œuf, à la pâte d'arachide ou au beurre de karité. Ou bien d'autres aliments tels que l'igname sous forme de pâte enrichie à l'huile ou au beurre de karité. • Donner en plus 2 repas familiaux sans épice • Donner 2 goûters : yaourt, œuf dur, galette, pain garni, fruit de saison, etc. 	 • Donner 1 bouillie de céréales enrichies au lait, à l'huile, à l'œuf, à la pâte d'arachide ou au beurre de karité ou bien d'autres aliments tels que l'igname sous forme de pâte enrichie à l'huile ou au beurre de karité. • Donner en plus 2 repas familiaux sans épice. • Donner 2 goûters : yaourt, œuf dur, galette, pain garni, fruit de saison, etc. 

PFE N°4: RELATIVE A LA SUPPLEMENTATION EN VITAMINE A ET AU DEPARASITAGE DE

L'ENFANT :

La mère, le père, le gardien d'enfant fait supplémenter les nourrissons et les enfants (6-59 mois) en Vitamine A et les fait déparasiter (12-59 mois) tous les 6 mois

PRINCIPAUX RÔLES DE LA VITAMINE A DANS L'ORGANISME HUMAIN

- Renforcement de la résistance contre les infections
- Stimulation de la croissance de l'enfant
- Protection contre les maladies des yeux, surtout chez l'enfant.
- Rôle dans la reproduction

QU'EST CE QUE LA CARENCE EN VITAMINE A?

C'est lorsque la vitamine A manque ou n'est pas suffisante pour couvrir les besoins du corps.

LES CAUSES DE LA CARENCE EN VITAMINE A

1. Insuffisance d'apport en vitamine A alimentaire

- Aliments riches en vitamine A (ARVA) saisonniers et trop coûteux.
- Régime pauvre en aliments riches en vitamine A chez les enfants.
- Nourrissons non allaités exclusivement jusqu'à 6 mois.
- Insuffisance des connaissances des parents en matière de nutrition.
- État d'urgence (guerre, catastrophes).

2. Troubles de l'absorption et de l'utilisation de la vitamine A

- Diarrhée : malabsorption intestinale et déperdition de la vitamine A.
- Régime pauvre en graisse, en protéines nécessaires à l'absorption et à l'utilisation de la vitamine A.

3. Utilisation rapide ou besoin élevé en vitamine A

- Dans les circonstances suivantes: -
- Croissance de l'enfant
- Maladies fébriles

COMMENT RECONNAITRE LA CARENCE EN VITAMINE A ?

Premier signe de la carence en vitamine A

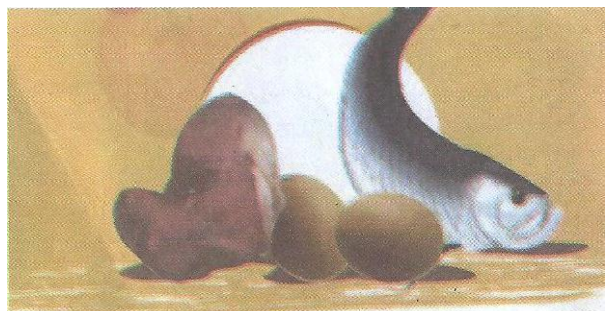
- Difficulté ou incapacité de voir lorsque l'éclairage est insuffisant (crépuscule ou la nuit = cécité nocturne)
- Majorité des enfants ayant une carence en vitamine A ne présente aucun signe mais ont un risque élevé de mourir (diarrhée, rougeole, toux grave)
- En absence de traitement de la carence, l'enfant présente des complications ~ qui peuvent aller jusqu'à la perte de la vue

LES SOURCES DE LA VITAMINE A

Deux sources d'origine alimentaire:

Origine animale (vitamine A pure)

- foie des animaux,
- jaune d'œuf,
- produits laitiers,
- poissons entiers,
- graisse de poissons....



2. Origine végétale (provitamine A ou caroténoïde):

- Fruits et légumes à chair orange ou jaune foncé
- feuilles vert foncées.



NB: Le régime alimentaire doit contenir également des graisses et des protéines pour permettre l'absorption et le transport de la vitamine A contenue dans ces produits.

MOYENS DE LUTTE CONTRE LA CARENCE EN VITAMINE A

1. Promotion de la production des aliments riches en vitamine A
2. Éducation nutritionnelle
3. Enrichissement des aliments en vitamine A ou fortification
4. Supplémentation en vitamine A

ADMINISTRATION DE LA VITAMINE A

Age	Capsule de vitamine A 100 000 UI (bleu)	Capsule de Vitamine A 200 000 UI (rouge)
Jusqu'à 6 mois		
De 6 à 11 mois	1 capsule	1/2 capsule (3 à 4 gouttes)
De 12 à 59 mois	2 capsules	1 capsule

Que doit faire l'ASC?

- L'agent de santé communautaire doit s'assurer que l'enfant reçoit les quantités adéquates de vitamine A soit dans la ration alimentaire ou sous forme de capsules de vitamine A
- Il doit recenser dans la communauté les enfants âgés de 6 à 59 mois absents des séances de vaccination/supplémentation en vitamine A antérieures
- Mobiliser la population cible du village/campement concerné sur le lieu, le jour, la date et l'heure de la vaccination/supplémentation en vitamine A
- Il doit aider l'infirmier du centre de santé, en informant la communauté de la date du passage de la stratégie avancée ou mobile
- Il doit aider l'agent de santé lors des activités de stratégies avancées ou mobile, en donnant les doses de vitamine A aux enfants, en remplissant les fiches et en comptant le nombre d'enfants supplémentés
- Il doit animer une séance de sensibilisation sur la vitamine A avant la séance de vaccination/supplémentation en vitamine A. et il peut supplémenter les enfants.

LE DEPARASITAGE DES ENFANTS

DEFINITION

• **Vers intestinaux :**

Parasites qui se développent dans le ventre de l'enfant et rendent l'enfant malade Déparasitage = éliminer ou tuer les vers.

COMMENT RECONNAITRE QU'UN ENFANT A DES VERS?

On reconnaît que l'enfant a des vers intestinaux devant les signes suivants:

- Il maigrit
- Il se gratte l'anus
- Il est faible
- il fait la diarrhée
- il a mal au ventre
- il devient pâle.
- il a le ventre gonflé

QUELQUES EXEMPLES DE VERS INTESTINAUX

- Ascaris,
- Giardia,
- Oxyures,
- Ténia,
- Amibes,
- Ankylostomes

PRINCIPAL MODE DE TRANSMISSION

COMMENT LES VERS SE RETROUVENT DANS LE VENTRE ?

Par la bouche : Terre contaminée, Mains sales, Consommation de l'eau souillée des marigots

Exemples de vers : ascaris, oxyures, amibes, giardia

PREVENTION

- Lavage correct des mains avec de l'eau propre et du savon avant préparation des repas
- Lavage correct des mains avec de l'eau propre et du savon avant et après le repas
- Elimination correcte des selles dans les latrines
- Lavage correct des mains après avoir fait les selles
- Protection des aliments contre les mouches
- Bonne cuisson de la viande de porc
- Eviter les baignades dans les eaux sales

LE DEPARASITAGE DES ENFANTS

Traitement contre les vers intestinaux

- Tout enfant doit être déparasité à partir de l'âge d'un an. Ceci doit être répété tous les six (6) mois. Le médicament à utiliser par l'ASC est **l'albendazole (400 mg)** ou le **mébendazole (500 mg)** qui se donne en prise unique.

Que doit faire l'ASC?

- Assurer la communication interpersonnelle sur la parasitose intestinale et le déparasitage systématique
- conseiller aux membres du ménage de se laver les mains à l'eau et au savon après les selles, avant et après les repas
- Déparasiter tous les enfants de 12 à 59 mois
- Orienter tous les enfants non déparasités vers le centre de santé ou lors des séances de vaccination en cas de rupture de déparasitant

CONCLUSION

- Important de connaître le rôle de la vitamine A, les signes cliniques de la carence en vitamine A et les signes qui font penser aux vers intestinaux chez un enfant.
- Mieux comprendre la nécessité de supplémenter en vitamine A et de déparasiter les enfants.

Les ménages consomment tous les jours du Sel Iodé dans leur alimentation

DEFINITIONS

Carence en iode

Apports insuffisants en iode pour couvrir les besoins de l'organisme.

L'iode

- Substance chimique
- Présence : en très petite quantité dans sol, aliments et eau
- Indispensable au fonctionnement normal de la glande thyroïde et à la production d'hormones thyroïdiennes
- Élément essentiel pour la croissance et le développement harmonieux de l'organisme.

Aliments riches en iode

❖ **Produits de mer :**

- Poissons,
- coquillages,
- Algues

❖ **Aliments d'origine animale :**

- Viande,
- lait

Aliments fortifiés

QUELLES SONT LES MANIFESTATIONS DE LA CARENCE EN IODE ?

Troubles dus a la carence en iode :

❖ **Chez le fœtus :**

- Avortements
- Mort in utero
- Anomalies congénitales

❖ **Chez le nouveau-né**

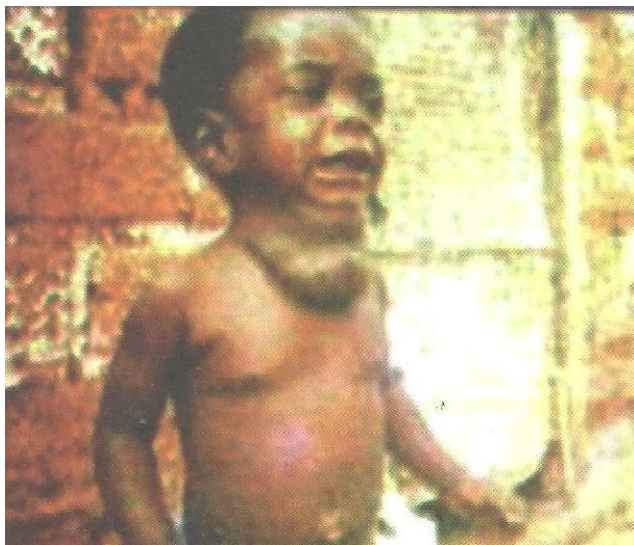
- Goitre néonatal
- Crétinisme (idiotie)
- Surdi-mutité (sourd-muet)
- Trouble psychomoteur
- Enfant de petits poids à la naissance

❖ **Chez l'enfant et l'adolescent**

- Goitre
- Diminution des facultés intellectuelles
- Retard du développement physique

Chez l'adulte

- Goitre avec ses complications
- Facultés mentales réduites



COMMENT PREVENIR LES TROUBLES DUS A LA CARENCE EN IODE ?

❖ Promouvoir la consommation d'aliments riches en iode:

- Produits de mer: poissons, crevettes, crabes,
- Algues
- Aliments d'origine animale: viande, lait, œufs

❖ Sensibiliser les ménages à détoxifier les aliments qui favorisent le développement du goitre (manioc cru, chou cru, etc.)

❖ Sensibiliser les ménages à consommer du sel iodé Solution actuelle :

l'iodation universelle du sel

Pourquoi doit-on consommer le sel iodé?

- Coûte moins cher
- Consommé par tout le monde
- Trouble psychomoteur
- Enfant de petits poids à la naissance
- Meilleur moyen de lutte contre les TDCI
- Apporte quotidiennement de l'iode
- Ne nécessite pas de personnel spécial ou équipement médical quelconque
- Protège contre le goitre
- Protège les enfants contre le retard de croissance et le retard intellectuel

TECHNIQUE DE CONTROLE RAPIDE DU SEL IODE

Les étapes de la démonstration :

- ✓ Le kit du test rapide utilisé en Côte d'Ivoire comprend :
- ✓ Deux flacons de la solution de sel iodé de couleur claire
- ✓ Un flacon de la solution de confirmation
- ✓ Un nuancier à 3 couleurs (blanche, faiblement violet ou bleu clair, violet foncé) qui permet de déterminer la quantité d'iode contenue dans le sel.
- ✓ Vérifier que le kit est complet
- ✓ S'assurer que le réactif n'est pas périmé

NB : Marquez la date d'ouverture sur le flacon

- ✓ Sortir le réactif de son emballage
- ✓ Prélever une petite quantité ou une mesure (cuillère à café, doseur, etc.) de sel iodé
- ✓ Verser une goutte de solution test sur le sel;
- ✓ En fonction de la quantité d'iode contenue dans le sel testé, la couleur variera du blanc au violet foncé
- ✓ Dans le cas où la couleur du sel testé ne change pas, faire un test de confirmation avec la solution de contrôle à fermeture rouge en versant une goutte de cette solution au même endroit que la solution test
- ✓ Utiliser le nuancier pour comparer l'intensité de la couleur et déterminer le taux de l'iode dans le sel testé

Trois cas peuvent se présenter:

- Le sel testé devient violet foncé = sel adéquatement iodé
- Le sel testé devient faiblement violet ou bleu clair = faible quantité d'iode

Le sel testé ne change pas de couleur = sel non iodé

- ✓ Ranger les différents éléments dans l'emballage
- ✓ Ranger le kit.

CONDITIONS D'UNE BONNE CONSERVATION DU SEL IODE**Gestes à faire :**

- ✓ acheter uniquement du sel iodé protégé
- ✓ mettre le sel iodé dans un bocal ou un sachet sec et fermé à l'abri de l'humidité
- ✓ ajouter du sel iodé à la cuisson

Importante savoir :

- ✓ Ne pas laisser le sel iodé à l'air libre (car l'iode est volatil)
- ✓ Ne pas laisser le sel iodé près du feu, sous le soleil
- ✓ Ne pas mettre en contact le sel iodé avec l'eau (éviter les endroits humides, les récipients humides)

Que doit faire l'ASC?

- Organiser des séances d'animation dans la communauté en vue de sensibiliser les populations sur l'importance d'acheter et de consommer du sel iodé
- Organiser des séances d'animation dans la communauté en vue de sensibiliser les populations sur les méthodes de conservation du sel iodé
- Procéder à un contrôle de la qualité du sel dans les ménages dont il a la charge
- Il faut bien noter le suivi de la consommation du sel iodé par le ménage dans le cahier de suivi de l'ASC

CONCLUSION

Informations sur TDCI = utiles aux acteurs sur le terrain pour mettre en place des stratégies de lutte intégrées dans leurs activités.

Mais ces stratégies ne suffiront pas, car il s'agit essentiellement de changement de comportement. Donc nécessité de mobiliser et de sensibiliser tous les acteurs de la santé et de la communauté.

PFE N° 6: RELATIVE A LA VACCINATION :

La mère, le père, la personne à charge de l'enfant fait vacciner complètement l'enfant avant l'âge de 1 an

Définition d'un vaccin

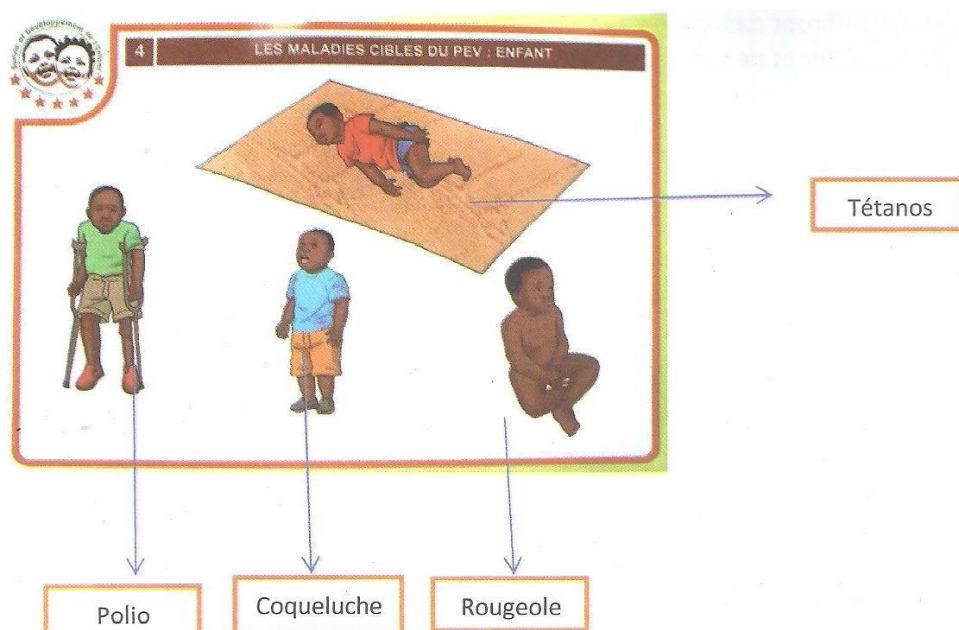
- **Vaccin** = médicament très fort
 - aide le corps à se défendre contre certaines maladies
 - Pour chaque maladie, il y a un vaccin différent qui se présente sous la forme de piqûre ou de liquide à boire.

Les raisons pour lesquelles on vaccine les enfants:

- Corps de l'enfant pas encore fort pour se défendre contre les maladies
- Les enfants peuvent mourir de maladies graves avant leur 1er anniversaire de vie, s'ils ne sont pas vaccinés
- Ils peuvent être aussi handicapés
- Les vaccins protègent les enfants contre ces maladies.
 - Nécessité de plusieurs vaccinations pour qu'un enfant soit complètement protégé.
 - Tous parents doivent savoir pourquoi, quand, où et combien de fois l'enfant doit être vacciné
- Les femmes en âge de reproduction doivent se faire vacciner pour la bonne santé de leurs bébés qui vont naître et pour leur propre bien.

Maladies cibles du Programme Elargi de Vaccination (PEV) 9 (neuf) maladies cibles du PEV

- tuberculose
- diphtérie
- tétanos
- coqueluche
- poliomyélite
- rougeole
- fièvre jaune
- hépatite B
- Les infections à *hémophilus influenzae* (méningite, pneumonie),



Cibles et objectifs du PEV

Populations cibles prioritaires du PEV

- Enfants 0-11 mois
- Femmes de 15-49 ans (femmes enceintes)

Objectifs

- Vacciner tous les ans > 80% populations cibles
- Éliminer le Tétanos néonatal
- Éradiquer la poliomyélite
- Contrôler la rougeole et la fièvre jaune

Calendrier de vaccination de l'enfant

Age	Vaccins	Maladies contre lesquelles il faut vacciner
A la naissance	BCG Polio 0	Tuberculose Poliomyélite
6 semaines (1mois $\frac{1}{2}$)	DTCHePBHib1+ Polio 1	Diphtérie, Coqueluche, Tétanos, Hépatite B, méningite et pneumonie à Haemophilus influenzae b, Poliomyélite
10 semaines	DTCHePBHib2+ Polio 2	Diphtérie, Coqueluche, Tétanos, Hépatite B, méningite et pneumonie à Haemophilus influenzae b, Poliomyélite
14 semaines	DTCHePBHib3+ Polio 3	Diphtérie, Coqueluche, Tétanos, Hépatite B, méningite et pneumonie à Haemophilus influenzae B, Poliomyélite
9 mois	VAR VAA	Rougeole Fièvre jaune
16 mois	1 ^{er} rappel DTCHePBHib+Polio	Diphtérie, Coqueluche, Tétanos, Hépatite B, méningite et pneumonie à Haemophilus influenzae b, Poliomyélite

Calendrier vaccinal de la femme en âge de reproduction

On vaccine la femme en âge de reproduction pour protéger le bébé qui va naître contre le tétanos. La femme aussi est protégée.

Antigène	Date	Durée de protection
VAT1*	1 ^{er} contact ou début de grossesse	Aucune
VAT2	1 mois après VAT1	3 ans
VAT3	6 mois après VAT2	5 ans
VAT4	1 an après VAT3	10 ans
VAT5	1 an après VAT4	Toute la vie

Vaccination Antitétanique

Carnet de santé et carte de vaccination

- Ils sont les supports de la vaccination
- Ils doivent mentionner au moins le vaccin administré, la date d'administration, le numéro du lot du vaccin et le service vaccinateur
- Toute femme en âge de reproduction doit avoir sa carte individuelle de vaccination indiquant le nombre de doses VAT reçues

Que doit faire l'ASC?

- Conseiller les mères et les parents
 - *La vaccination offre une protection contre plusieurs maladies dangereuses.*
 - *Un enfant qui n'est pas vacciné court beaucoup de risque de souffrir de maladies graves ou d'être handicapé.*
 - *Il est impératif de faire vacciner un enfant. Il devrait recevoir tous les vaccins avant l'âge d'un an.*
 - *Toutes les femmes en âge de reproduction doivent être vaccinées contre le tétanos.*
 - *Susciter l'amour de la vaccination auprès des mères,*
- Participera l'organisation des vaccinations,
- Recenser dans la communauté les enfants non vaccinés et le conduire au centre de santé
 - Mobiliser la population cible du village/campement concerné sur le lieu, le jour, la date et l'heure de la vaccination
- Aider l'infirmier du centre de santé, en informant la communauté de la date du passage de la stratégie avancée
- Aider l'agent de santé lors des activités de stratégie avancée, en donnant les gouttes de VPO, en remplissant les fiches de pointage et en comptant le nombre d'enfants vaccinés.
- Animer une séance de sensibilisation sur la vaccination avant la séance.
- Inciter les mères et les pères à venir vers lui en cas de problème de santé.
- Bien noter le suivi vaccinal dans le cahier de suivi de l'ASC.

Important : Toutes les vaccinations sont gratuites

A retenir

- La vaccination est un droit pour l'enfant et un devoir pour la mère, le père et la personne à charge de l'enfant.
- Il faut bien noter le suivi vaccinal dans le cahier de suivi de l'ASC.
- Toutes les vaccinations sont **gratuites jusqu'à l'âge de 1 an.**

PFE N° 7: RELATIVE AU LAVAGE DES MAINS :

La mère, le père ou la personne à charge de l'enfant lave ses mains avec de l'eau propre et du savon et observe les bonnes pratiques d'hygiène du milieu :
- avant de préparer les repas des enfants, avant de nourrir les enfants,
- après la défécation, après avoir éliminé correctement les selles des enfants

Définition :

L'hygiène c'est l'ensemble des mesures et de précautions destinées à prévenir les maladies et à maintenir la santé. Elle se base sur:

- Le lavage correct des mains
- l'hygiène du milieu
- l'utilisation des latrines et des douchières, la conservation et la consommation de l'eau potable (6 jours de conservation).
- L'hygiène alimentaire (préparation et conservation des aliments).

Importance du lavage des mains au savon

- Moyen efficace pour prévenir les maladies (diarrhée, pneumonie)
- Préserve la santé en évitant de se contaminer ou de contaminer quelqu'un d'autre
- Le savon décompose les graisses, les saletés et les microbes ; il facilite le frottement et la friction qui les délogent et donne aux mains une senteur agréable.

Moment du lavage des mains

- avant de faire la cuisine, de manipuler les aliments
- avant de manger (avant les repas), et de donner à manger aux enfants
- avant d'allaiter le bébé
- après avoir été aux toilettes ou aux latrines ou avoir nettoyé les selles des enfants
- en rentrant à la maison, au retour du travail ou de l'école,
- après le balayage/nettoyage (avoir fait le ménage)
- après toute manipulation de volaille ou après contact avec les animaux domestiques
- après avoir utilisé des produits chimiques.

Les maladies qu'on peut éviter par le lavage des mains

- Les diarrhées, Le choléra, La fièvre typhoïde, La poliomyélite, Le rhume
- Les infections respiratoires aiguës (ex : pneumonie), Infections par les vers intestinaux
- Infections de la peau (dermatoses), Infections des yeux (conjonctivites), Le trachome
- L'hépatite, La grippe aviaire et la grippe H INI, etc.

Technique du lavage correct des mains à l'eau et au savon

- Mouiller les mains
- Couvrir de savon les mains humides (savonner ensuite les mains)
- Frotter pendant au moins 20 secondes aussi bien les paumes, les dos des mains, les entre-doigts, le dessous des ongles, les poignets
- Bien rincer à l'eau courante, c'est eau qui coule au lieu de rincer à l'eau stable » Sécher soit avec du tissu propre ou en secouant à l'air libre

NB : A défaut de savon, la cendre peut aussi être utilisée dans des endroits où les populations n'ont pas de savon.

La femme enceinte et les enfants de 0-5 ans dorment toutes les nuits sous Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action (MILDA)

Définition du paludisme

- Le paludisme est une maladie parasitaire due au plasmodium qui est un parasite inoculé à l'homme par les piqûres de certains moustiques appelés "anophèles femelles" (femelle du moustique).
- Maladie infectieuse grave, qui peut être mortelle si des soins appropriés ne sont pas apportés.
- Affection tropicale la plus répandue dans le monde.

Les causes du paludisme

- **Seule cause** = piqûre de certains moustiques appelés "anophèles femelles" (femelle du moustique).
- **Paludisme et grossesse:** le paludisme entraîne une anémie qui est un des facteurs de mortalité maternelle et fœtale. Le paludisme est à l'origine :
 - d'avortements
 - d'anémies sévères
 - de fœtus morts
 - d'accouchements prématurés
 - de faible poids à la naissance.

Facteurs de propagation

- **Manque d'hygiène du milieu:**
 - Eau stagnante :
 - mares, marécages,
 - flaques d'eau, fosses, caniveaux non curés
 - vieilles boîtes de conserve, vieux pneus ou empreintes de sabots de bétails,
 - humidité sur les longues herbes et dans la broussaille etc.
- **Les moustiques peuvent également se reproduire le long des rives, des cours d'eau, dans les récipients à eau, dans les citernes et les rizières**

Les mesures préventives du paludisme

Stratégies de lutte contre le paludisme:

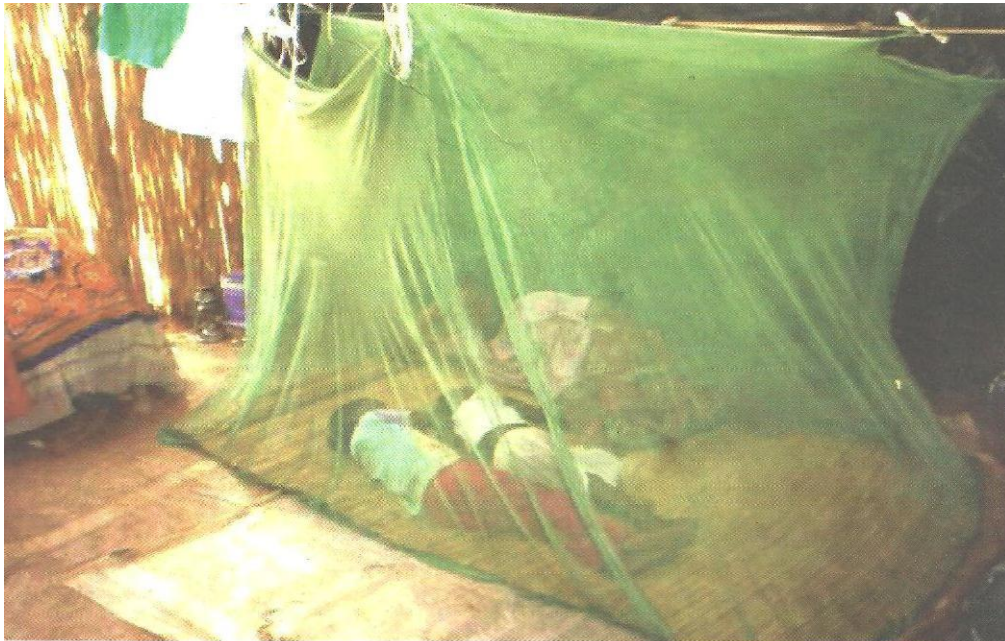
Quatre stratégies :

- La chimio-prophylaxie des sujets à risque. Médicaments donnés (femmes enceintes, enfants, touristes...)
- Utilisation de produits chimiques dans l'environnement
- Hygiène de l'environnement
- Utilisation de la MILDA

Pourquoi faut-il dormir sous la MILDA? Quels sont les avantages de la MILDA ?

- Elle protège toute la nuit contre les piqûres de moustiques et chasse tous les autres insectes
- Elle est efficace et **tue le moustique** et insectes
- Elle **coûte moins chère par rapport au coût du traitement.**
- La durée d'action du produit utilisé pour l'imprégnation est de 5 ans.

Modèle d'utilisation de la MILDA



Ce que l'agent de santé communautaire doit faire

- Organiser des séances d'animation dans la communauté en vue de sensibiliser les populations sur l'importance de dormir toutes les nuits sous moustiquaires imprégnées en particulier les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.
- Bien noter le suivi de l'acquisition des moustiquaires imprégnées par les femmes enceintes lors de la consultation prénatale (CPN) et par les enfants de moins de 5 ans.
- Bien noter le suivi de l'utilisation des moustiquaires imprégnées par les femmes enceintes et par les enfants de moins de 5 ans toutes les nuits.

La mère, le père ou la personne à charge de l'enfant donne à l'enfant le traitement adéquat à domicile :

- de la diarrhée
- de la fièvre et du paludisme
- des Infections Respiratoires Aigües (IRA)

LA DIARRHEE

Définition de la Diarrhée

- La diarrhée est l'émission d'au moins trois selles molles ou liquides par jour
- Les selles peuvent contenir du sang ou de la glaire (morve). Dans ce cas, la diarrhée est
- appelée diarrhée avec sang dans les selles.

Attention

- Toute personne qui émet des selles molles ou liquides au moins trois fois par jour peut être considérée comme ayant la diarrhée
- Des selles normales mais fréquentes ne signifient pas qu'il y a diarrhée
- Les enfants nourris au sein ont souvent des selles molles mais il ne s'agit pas non plus de diarrhée
- Le nombre de selles normalement évacuées par jour dépend de l'alimentation et de l'âge de l'individu
- Chez le jeune enfant, la mère est la mieux placée pour savoir s'il fait ou non la diarrhée.

Pourquoi la diarrhée est-elle dangereuse ?

La diarrhée est dangereuse parce qu'elle fait perdre au corps de l'enfant beaucoup d'eau et de sels minéraux : c'est la déshydratation. Elle peut provoquer la malnutrition et même entraîner la mort de l'enfant.

Facteurs favorisant la diarrhée

- Saleté / manque d'hygiène
- Mauvaise hygiène des aliments (ex : manger des aliments mal cuits), Boire de l'eau sale
- Allaitement artificiel non hygiénique
- Manger sans laver les mains à l'eau et au savon
- Manger des aliments sur lesquels les mouches et les saletés (ou la poussière) se sont déposées
- Non-respect de l'AME jusqu'à 6 mois.
- La dysenterie liée à l'alimentation.
- Intoxication alimentaire
- Ne pas se laver les mains à l'eau et au savon après les selles
- Manger des aliments avariés « Sevrage brusque et mal adapté
- Dentition chez l'enfant
- Maladies infectieuses, parasitaires et virales (ex : palu, choléra, rougeole, typhoïde, le SIDA, etc.)

Signes de complication de la diarrhée

- Nombreuses selles liquides
- Vomissements répétés
- Soif prononcée
- Manque d'appétit, absence de soif
- Fièvre
- Sang dans les selles
- Déshydratation

Signes de reconnaissance de la déshydratation

- Fatigue
- Yeux enfoncés
- Soif
- Irritabilité
- lorsque l'on pince et relâche la peau du ventre, le pli s'efface lentement.

La prise en charge de la diarrhée de l'enfant

En plus du traitement de la cause de la diarrhée, il faut donner plus fréquemment le lait maternel à l'enfant avant l'âge de 6 mois, et après 6 mois continuer à donner plus de liquide (y compris le lait maternel!) et plus d'aliments à l'enfant malade.

4 règles pour sauver l'enfant qui a la diarrhée

1. Donner davantage à boire à l'enfant
2. Donner des comprimés de zinc
3. Donner à manger à l'enfant en plusieurs petits repas
4. Emmener l'enfant au centre de santé si son état ne s'améliore pas.

Préparation de la SRO

- Se laver les mains au savon et à l'eau
- Mesurer un (1) litre d'eau propre
- Verser le contenu du sachet dans le litre d'eau
- Mélanger bien pour dissoudre la poudre
- Goûter la solution afin d'en connaître la saveur

Quelle quantité de SRO donner ?

- Donner davantage à boire à l'enfant dès le début de la diarrhée.
- Donner aux enfants de moins de 2 ans : environ 50 à 100 ml de SRO) après chaque selle molle ou liquide.
- Donner aux enfants de 2 à 5 ans : 100 à 200 ml de SRO) après chaque selle molle ou liquide.

Quels autres liquides peut-on donner à l'enfant qui a la diarrhée?

- Les liquides conseillés sont : SRO, soupe, eau de riz (bouillie de riz), jus de coco frais, yaourt liquide, lait caillé, eau potable, etc.
- Si l'enfant a moins de 6 mois et ne mange pas encore d'aliments solides, augmenter la fréquence des tétées, lui donner la SRO ou de l'eau potable et non un liquide à base d'aliments.

Remarques importantes

- Préparer chaque jour une nouvelle solution de SRO dans un récipient propre. Garder le récipient couvert. La solution peut être conservée et utilisée pendant une journée (24 heures). Jeter toute solution restante du jour précédent.
- Les boissons gazeuses, très sucrées telles qu'infusions, limonades ou boissons fruitées du commerce sont à proscrire.

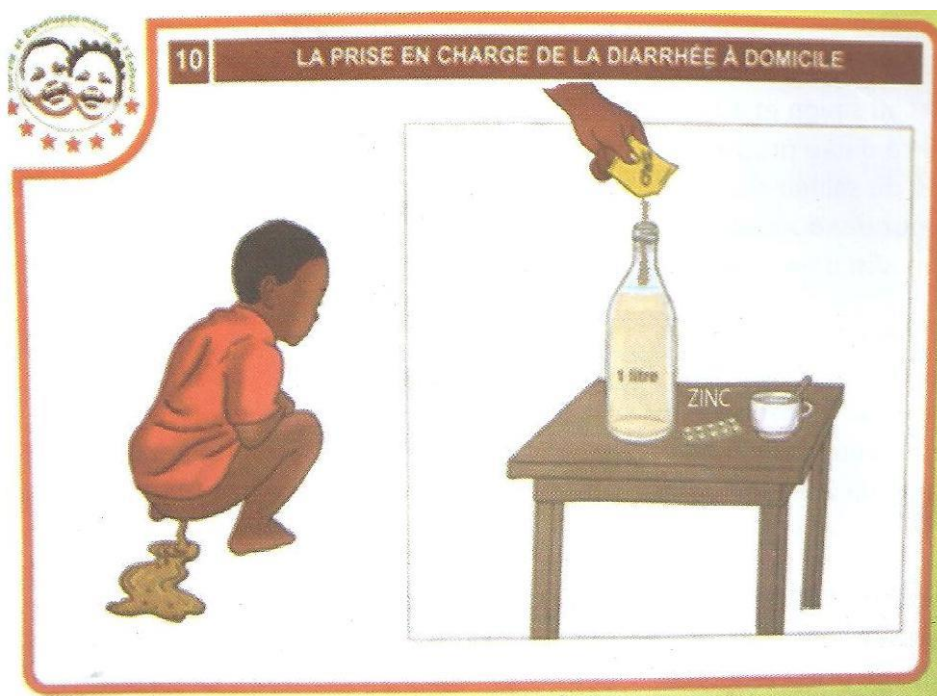
Comment donner le zinc à l'enfant?

Dissoudre le comprimé dans un peu de lait maternel, de SRO ou d'eau propre, dans une tasse ou une cuillère :

- enfant de moins de 6 mois : 1/2. cp par jour pendant 14 jours
- enfant de 6 mois et plus: 1 cp par jour pendant 14 jours

Mesures de prévention

- Lavage des mains au savon et à l'eau propre
- Allaitement exclusif au sein jusqu'à 6 mois
- Bonne pratique du sevrage
- Utilisation des latrines
- Utilisation d'eau propre en abondance
- Élimination hygiénique des selles des enfants
- Respect du calendrier vaccinal de l'enfant
- Protection contre la transmission du VIH.



LA FIEVRE/PALUDISME

La prise en charge de la fièvre

- L'ASC peut aider la population à mieux se protéger contre le paludisme

Qu'est-ce que la fièvre ?

- C'est lorsque la température de l'enfant est supérieure 37,5°C (ajouter 0,5°C à la T° axillaire)
- Ou en l'absence de thermomètre, c'est une sensation de corps chaud au toucher.

Qu'est-ce que le paludisme ?

- C'est une maladie parasitaire due à la présence dans le sang d'un parasite appelé "plasmodium".
- Ce parasite, une fois dans le sang, détruit les globules rouges. C'est ce qui donne la fièvre ou corps chaud et l'anémie qui est le manque de sang dans le corps.

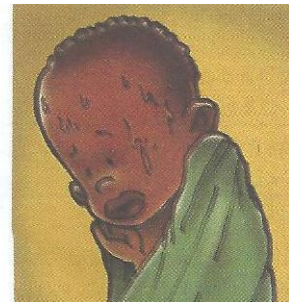
Les signes cliniques du paludisme:

Le paludisme est aujourd'hui classifié sous deux formes cliniques :

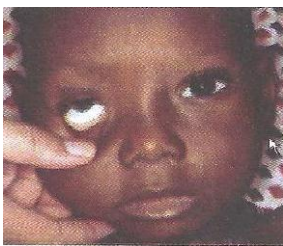
- le paludisme simple
- le paludisme grave

Signes du paludisme simple:

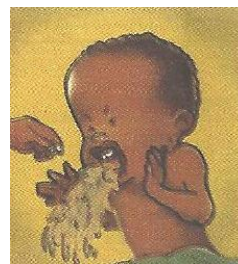
- Fièvre
- maux de tête
- courbatures
- douleurs articulaires
- Affaiblissement général
- nausées, vomissements
- Manque d'appétit



Signes du paludisme grave:



Anémie ou manque de sang



Vomissements



Convulsion ou maladie
de l'oiseau

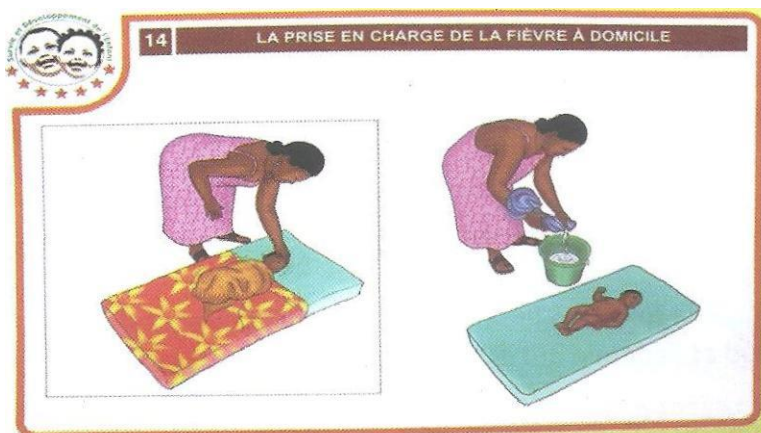


Coma

Comment traiter le paludisme à domicile?

1-faire baisser la fièvre :

a. Il faut envelopper l'enfant qui a le corps chaud (forte fièvre) dans une serviette ou un pagne trempé dans l'eau. Recommencer l'enveloppement humide jusqu'à ce que la fièvre baisse.



b. Donner à l'enfant un antipyrétique (paracétamol) pour faire baisser la fièvre.

Le paracétamol se prend par voie orale en 4 prises en fonction du poids (toutes les 6 heures). A défaut de paracétamol, il faut utiliser de l'Aspirine (**Acide acétyl salicylique**).

ÂGE ou POIDS	Paracétamol			Acide acétyl salicylique		
	Comp 500 mg	Sachet 300 mg	Sachet 80 mg	Sachet 250 mg	Comp 500 mg	Comp 100 mg
de 2 mois à 3 ans (4 à <14 kg)	1/4	-	1	1/2	1/4	1
de 3 ans à 5 ans (14 à <19 kg)	1/2	1	2	1	1/2	1et 1/2

2-Traiter le paludisme avec les comprimés de CTA pendant 3 jours après le Test de Diagnostic Rapide (si l'ASC a été formé à cela):

Age de l'enfant	Présentation du médicament	1 ^{er} jour	2 ^{ème} jour	3 ^{ème} jour
2-11 mois (4,5-8 kg)	Artésunate (25 mg)+ Amodiaquine (67,5 mg)	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé
1-5 ans (9-17 kg)	Artésunate (50 mg)+ Amodiaquine (135 mg)	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé

Ce que l'agent de santé communautaire doit faire

- donner la première dose d'antipyrétique
- encourager la personne à charge de l'enfant à suivre correctement le traitement pendant les 3 jours
- conseiller la personne à charge de l'enfant d'éviter de trop habiller ou de trop couvrir l'enfant
- conseiller les mesures de prévention à la mère, au père ou à la personne à charge de l'enfant
- enregistrer les cas de paludisme dans le Registre de l'ASC

NB : En cas de signe de danger ou de complication, l'ASC doit placer à l'enfant un suppositoire d'Artésunate 50 mg et le transférer rapidement au centre de santé.

LA TOUX OU LES DIFFICULTES RESPIRATOIRES

La prise en charge de la toux ou du rhume chez l'enfant

- Lorsque l'enfant qui tousse ne présente pas de respiration rapide ou difficile il a une TOUX ou un RHUME.
- L'enfant qui respire normalement peut être soigné à domicile pour une toux ou un rhume sans médicament spécifique. Un remède inoffensif à base de miel et de citron est recommandé.
- Désobstruer (nettoyer) les narines de l'enfant avec de l'eau salée lorsqu'il est enrhumé.

Constitution du remède inoffensif

- Dons une *demi-tasse d'eau tiède, mettre deux cuillerées à café de miel et le jus d'un demi-citron vert pressé.*
- *Donner cette tisane à boire à l'enfant au moins 3 fois par jour.*

Qu'est-ce qu'une PNEUMONIE ?

- C'est une infection (maladie) des poumons de l'enfant.

Quels sont les signes de la pneumonie ?

- L'enfant tousse et respire beaucoup plus vite que d'habitude ou a du mal à respirer.
- Un enfant qui tousse peut respirer plus vite que d'habitude. Cela veut dire que la maladie s'aggrave.

Comment reconnaît-on une respiration rapide ?

On reconnaît une respiration rapide en comptant les mouvements respiratoires par minute. Un mouvement respiratoire comprend deux éléments:

- *L'entrée de l'air dans les poumons qu'on appelle l'inspiration et*
- *La sortie de l'air des poumons qu'on appelle l'expiration.*

Age	La respiration est rapide si...
Si l'enfant a de 0 à 2 mois	60 mouvements respiratoires par minute ou plus
Si l'enfant a de 2 mois à 12 mois	50 mouvements respiratoires par minute ou plus
Si l'enfant a de 12 mois à 5 ans	40 mouvements respiratoires par minute ou plus

La prise en charge de la pneumonie chez l'enfant

Traiter la pneumonie avec les Antibiotiques (si l'ASC a été formé à cela):

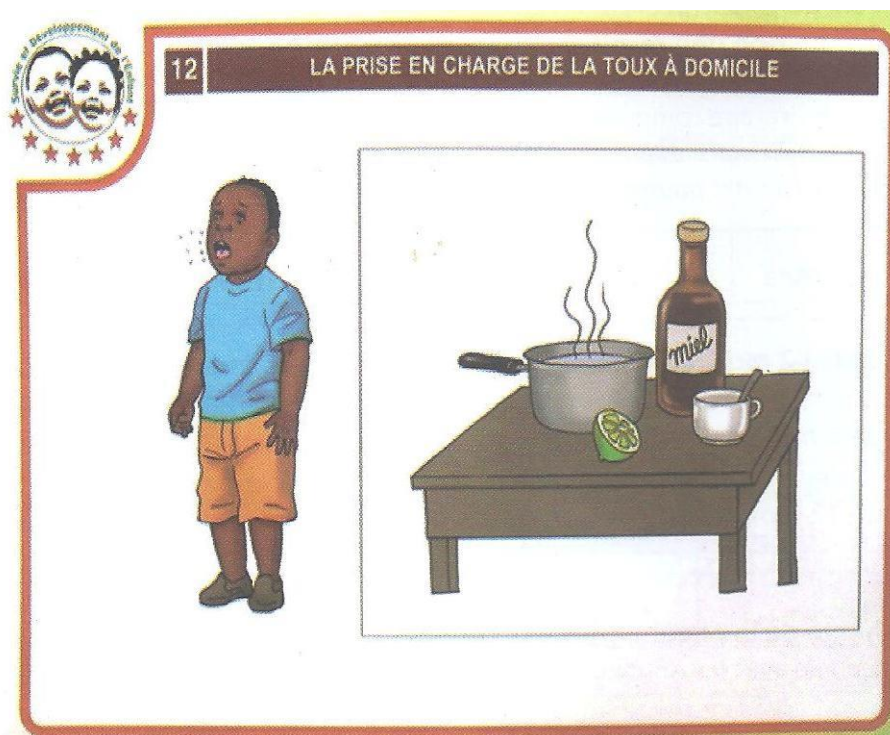
AGES OU POIDS	AMOXICILLINE		
	Donner trois fois par jour pendant 5 jours		
	Sirop 500 mg	Sirop 250 mg	Sirop 125 mg
De 2 mois à 12 mois (4 à <10 kg)		2,5 ml (1/2 c à c)	5 ml (1 c à c)
De 12 mois à 5 ans (10 à 19 kg)	2,5 ml (1/2 c à c)	5 ml (1 c à c)	10 ml (2 c à c)

Quand on soigne un enfant à domicile, il est important de :

- continuer à l'alimenter
- le tenir au chaud mais sans excès
- lui faciliter la respiration

Ce que l'agent de santé communautaire doit faire :

- Apprendre à la mère ou la personne à charge de l'enfant à préparer la tisane de miel au citron en cas de toux
- Reconnaître un cas de pneumonie et le traiter avec un antibiotique (Amoxicilline) si l'ASC est formé pour le faire
- Orienter l'enfant au centre de santé s'il n'ya pas d'amélioration, si des complications apparaissent, si l'état de l'enfant s'aggrave.



PFE N° 10: RELATIVE A LA RECONNAISSANCE DES SIGNES DE DANGER CHEZ L'ENFANT :

La mère, le père ou le gardien d'enfant reconnaît les signes de danger ou de gravité afin d'amener à temps l'enfant chez le prestataire qualifié au centre de santé pour recevoir les soins appropriés

Qu'est-ce qu'un signe de danger ?

- Tout enfant qui présente un signe de danger a un problème grave
- La plupart des enfants avec un signe de danger nécessite une référence d'urgence au centre de santé ou hôpital
- Nécessité de traitement de secours (Oxygénation, Antibiotique etc...)
- La mère ou le gardien d'enfant doit reconnaître les signes de danger chez tout enfant malade
- Egalement les signes de complications des maladies courantes de l'enfant.

Lorsqu'un de ces signes apparaît, l'enfant ne peut plus être traité à domicile, il faut l'envoyer d'urgence dans le centre de santé le plus proche pour qu'il reçoive les soins appropriés.

Comment reconnaître les signes de danger chez un enfant malade ?

Les signes de danger varient en fonction de l'âge de l'enfant. 2 tranches d'âges sont à retenir.

- De la naissance à 2 mois
- De 2 mois à 5 ans

Enfant de moins de 2 mois:

8 signes sont à rechercher, Ce sont :

1. Convulsions actuelles ou antérieures
2. Difficultés à se nourrir actuellement ou depuis quelques jours (incapable de téter)
3. Respiration rapide ou difficultés à respirer
4. Tirage sous costal exagéré ou prononcé (la respiration ne descend pas)
5. Geignement
6. Fièvre (Température à 38°C ou plus ; ajouter 0.5°C à la T° axillaire) ou corps chaud au toucher
7. Hypothermie ou refroidissement (Température en dessous de 36°C) ou corps froid au toucher
8. Bouge seulement s'il est secoué

Devant l'un de ces signes évoqués ci-dessus, le nourrisson doit être conduit immédiatement au centre de santé le plus proche.

Enfant de 2 mois à 5 ans:

5 signes sont à rechercher, ce sont :

1. Ne peut boire ou téter le sein de sa mère
2. Vomit tout ce qu'il consomme (vomissements répétés)
3. A eu des convulsions ou convulsé actuellement
4. Ne bouge presque pas, ne s'intéresse à rien autour de lui ou est inconscient
5. Devient plus malade.

Devant l'un de ces signes évoqués ci-dessus, l'enfant doit être conduit immédiatement au centre de santé le plus proche !

Comment reconnaître les signes de complications chez un enfant malade au cours du traitement à domicile ?

Lorsqu'un des signes ci-dessous apparaît au cours du traitement à domicile, la mère, le père ou le gardien d'enfant doit envoyer d'urgence l'enfant dans le centre de santé le plus proche

FIEVRE OU CORPS CHAUD

Tout enfant avec fièvre (corps chaud)

- Qui a reçu l'association artésunate - arnodiaquine (CTA) et chez qui la fièvre persiste après 2 jours de traitement
- Qui semble devenir plus malade
- Qui est incapable de boire ou de téter
- Qui convulsé ou a convulsé

DIARRHÉE

Tout enfant qui fait une diarrhée

- Qui boit difficilement
- Qui est sans déshydratation, mais a une diarrhée persistante
- Qui a des signes évidents de déshydratation
- Qui a du sang dans les selles

TOUX

Tout enfant qui présente une toux

- Qui ne s'améliore pas au bout de 2 jours
- Qui a une respiration rapide ou qui a une respiration difficile

MALNUTRITION

Tout enfant malnutri qui présente :

- Réapparition des œdèmes des membres inférieurs
- Perte de l'appétit

Quand revenir immédiatement au centre de santé?

Avant la date fixée pour le rendez-vous de suivi par l'agent de santé, l'enfant devra être ramené immédiatement au centre de santé, s'il présente certains signes d'alarme suivants:

Tout enfant malade qui :

- Est incapable de boire ou de téter
- Devient plus malade
- A de la fièvre

Tout enfant avec toux ou rhume, qui a :

- Une respiration rapide
- Une respiration difficile

Tout enfant faisant la diarrhée, qui a:

- Des selles contenant du sang
- Des difficultés à boire

Que doit faire l'ASC?

1. Référer immédiatement au centre de santé le plus proche

- Tout enfant malade qui présente un signe de danger
- Tout enfant traité à domicile pour une maladie donnée et qui présente un des signes de complications de la maladie

2. Faire des causeries éducatives de groupes ou des communications interpersonnelles (CIP) sur :

- les signes de gravité des maladies courantes de l'enfant
- les signes de danger chez tout enfant malade.

3. Déterminer de façon consensuelle avec la communauté, les moyens de transport, le coût et les modalités de financement du transfert des cas référés.

**PFE N° 11: RELATIVE A LA CONSULTATION PRENATALE ET A L'ACCOUCHEMENT ASSISTE PAR UN
PERSONNEL QUALIFIE:**

**La femme enceinte se fait suivre en Consultation Prénatale (CPN) et accouche
sous la surveillance d'un personnel qualifié**

Qu'est-ce que la consultation prénatale (CPN) ?

CPN = Surveillance médicale de la grossesse pour s'assurer que la mère et « l'enfant dans le ventre » se portent bien jusqu'à l'accouchement

Pourquoi la femme enceinte doit-elle faire la CPN ? la CPN permet de:

1. Confirmer la grossesse
2. Prévenir les maladies
3. Dépister les maladies
4. Traiter les maladies
5. Faire le suivi nutritionnel de la femme enceinte

Afin d'éviter les décès liés à la grossesse.

Quels sont les avantages de la CPN ?

- Prévention et soins de certaines maladies liées à la grossesse
- Suivi de l'état nutritionnel
- Conseil pour faire le test de dépistage du VIH
- Préparation de la femme enceinte à l'accouchement

Pour que Bébé se porte bien à la naissance et que la mère également se porte bien à l'accouchement.

Quels sont les avantages d'une alimentation équilibrée chez la femme enceinte?

1. Une bonne santé de la mère et de l'enfant
2. La prise normale de poids pendant la grossesse
3. La croissance normale de « l'enfant dans le ventre »
4. La diminution du risque d'accouchement prématuré ou de mort de « l'enfant dans le ventre »
5. Accouchement d'un enfant de poids normal (au-dessus de 2,5 kg)

Calendrier des CPN

	1ère CPN	2ème CPN	3ème CPN	4ème CPN
Date	3 mois	6 mois	7-8 mois	9 mois
But	Confirmer grossesse Date probable accouchement examens nécessaires	Prévenir Rechercher et Traiter maladies liées à la grossesse	Prévenir, Rechercher et traiter maladies Préparer l'accouchement	Préparer l'accouchement

Quelles sont les prestations dont bénéficie la femme enceinte lors de la CPN?

1. Conseils

- Hygiène alimentaire et corporelle
- Espacement des naissances,
- VIH/SIDA,
- vaccination...

2. Examen de la femme enceinte

- Examen du ventre
- Écoute de l'enfant dans le ventre

3. Recherche de maladies dans les urines

4. Recherche de maladies dans le sang

- Anémie,
- Maladies qui créent des malformations chez l'enfant,
- Maladies qu'on peut transmettre à l'enfant comme le VIH/ sida)

5. Prévention du paludisme

- distribution de moustiquaire imprégnée (MILDA)
- prescription du traitement préventif intermittent (TPI) : **Dose unique**= 3 comprimés de 500 mg de sulfadoxine + 25 mg de pyriméthamine. **Posologie**: 02 doses espacées d'au moins un mois
- première dose : à partir de la 16^{ème} semaine
- La dernière dose est donnée 01 mois avant le terme de la grossesse

6. Prévention de l'anémie

- Déparasitage à partir de la 16^{ème} semaine
- Supplémentation en fer et en acide folique 5mg :

Début du traitement : lors de la première CPN (CPN 1)

Dose= forme combinée: 1 comprimé de Fer + Acide folique par jour jusqu'à l'accouchement.

7. Vaccination contre le tétanos

VAT1 (1er contact au début de la grossesse) ;

VAT2 (1 mois après VAT1);

VAT3 (6moisaprèsVAT2);

VAT4 (1anaprèsVAT3);

VAT5 (1anaprèsVAT4)

8. Prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à son enfant

Distribution de médicaments aux mères séropositives

Quels sont les principaux signes de danger pendant la grossesse ?

1. Toute perte de sang, par voie vaginale (sang qui coule en bas)
2. Toute perte des eaux par voie vaginale
3. Apparition de contractions utérines (mal de ventre)
4. Fièvre
5. Céphalées intenses
6. Œdèmes
7. Manque de sang (les conjonctives, les paumes, la plante des pieds et le visage sont blancs)

Important : Devant tout signe de danger, il faut orienter (référer) la femme enceinte au centre de santé le plus proche pour des soins appropriés.

Quels sont les avantages de l'accouchement par un personnel de santé qualifié au centre de santé ?

1. Détecter et traiter rapidement les complications liées à l'accouchement:

- Perte de sang en abondance
- Fièvre (corps chaud) importante
- Convulsion
- Tension élevée pendant et après l'accouchement
- Travail trop long : mauvaise position

2. Prévenir (Eviter) la contamination de l'enfant par le VIH/sida

3. Avoir le certificat de naissance pour la déclaration de l'enfant

Comment préparer la femme enceinte à l'accouchement?

1. Combien coûtent:

- Le carnet de santé
- Le gant d'examen
- Les médicaments
- Les examens complémentaires (urine, sang)
- La césarienne (opération pour sortir l'enfant)

2. Déterminer de façon consensuelle avec la communauté, les moyens de transport, le coût et les modalités de financement du transfert des cas référés.

3. Organiser la communauté en vue de la constitution d'un fonds de solidarité pour les frais d'accouchement.

Ce que l'ASC doit faire

1. Identifier les cas de grossesse
2. Demander aux femmes enceintes de se rendre au centre de santé
3. Organiser des causeries de groupe sur l'importance de la consultation prénatale (CPN) et sur le VIH/sida
4. Effectuer des visites à domicile pour assurer le suivi de la CPN et de l'alimentation de la femme enceinte
5. Informer les femmes enceintes sur les signes de complication de la grossesse
6. Rechercher activement les femmes enceintes perdues de vue, les rendez-vous manqués et les abandons
7. Enregistrer tous les cas référés
8. Orienter les femmes en travail vers les centres de santé
9. Rechercher avec la communauté les moyens de transfert des cas de complications et des femmes en travail.

PFE N° 12: RELATIVE A LA CONSULTATION POST NATALE :

La mère se fait suivre après l'accouchement avec son enfant par un personnel qualifié

Quelle est l'importance de la consultation après l'accouchement ?

Permet de rechercher, traiter et/ou d'éviter les complications chez la mère et chez l'enfant.

Pour la mère :

- s'assurer que la mère allaite correctement (au sein)
- s'assurer que la mère infectée reçoit un médicament pour éviter la transmission du VIH à l'enfant.
- s'assurer qu'elle ne présente aucune maladie,
- prescrire/ donner le Fer/ folate et autres médicaments
- prescrire la méthode contraceptive adaptée

Pour le nouveau-né,

Cette consultation sera l'occasion de s'assurer que l'enfant est en bonne santé et de préciser les soins à donner, ce sont :

- Ne pas laver le nouveau-né immédiatement à la naissance
- Faire proprement les soins du cordon ombilical
- Ne rien mettre d'autre sur le cordon ombilical en dehors des produits conseillés par l'agent de santé
- Faire la vaccination (BCG, VPOO)

Calendrier du suivi après l'accouchement

Calendrier	Actions	Bénéfices pour la mère	Bénéfice pour enfant
Pendant les premières 48 H	Garder la mère et l'enfant pour surveillance au centre de santé	Reçoit les premiers soins en cas de complication	Reçoit les premiers soins en cas de complications
	Donner à la mère le fer/folate jusqu'au 45 ^{ème} jour	Prévention de l'anémie	-
	Faire la vaccination de l'enfant		Prévention de la tuberculose(BCG), de la poliomyélite (VPO 0)
	Donner le KIT PTME à l'enfant né de mère séropositive (ARV et Cotrimoxazole)		Prévention de la transmission du VIH à l'enfant
	Conseiller la mère de dormir avec son enfant sous une Moustiquaire Imprégnée d'insecticide à Longue Durée d'Action	Prévention du paludisme	Prévention du paludisme
Après 48 H	Amener l'enfant pour la pesée chaque semaine pendant le premier mois de vie	-	- soins néonataux - surveillance de la croissance
	Revoir la mère et l'enfant 6 semaines après l'accouchement	Conseils de nutrition, de planification familiale, allaitement exclusif	- Prévention contre la poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite b - Pratique allaitement exclusif

Ce que l'ASC doit faire

- Amener les mères à retourner avec leur enfant au centre de santé selon le calendrier de suivi après l'accouchement
- Vérifier que la méthode contraceptive prescrite est bien suivie
- S'assurer de la prise correcte des médicaments et de la vitamine A
- Donner des conseils sur l'allaitement exclusif
- Donner des conseils sur la vaccination de l'enfant
- Assurer le suivi de l'accouchée

ANNEXES SUR LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION

ANNEXES SUR LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION

I-DEFINITION

La VAD est une visite que l'on rend à une personne ou à une famille en vue de :

- Prodiguer des conseils
- Donner des informations sur un sujet précis
- Négocier l'adoption de nouveaux comportements
- Trouver une solution à un problème.

II - ÉTAPES DE RÉALISATION D'UNE VISITE À DOMICILE

1. Que faut-il faire avant :

- Identifier la famille
- Identifier le problème
- Fixer l'objectif de la visite (qu'est-ce que je veux faire exactement au sein de la famille?)
- Élaborer la stratégie d'approche (comment dois-je faire pour atteindre l'objectif fixé)
- Réviser les connaissances par rapport aux objectifs de la visite
- Préparer les supports que l'on voudrait utiliser (images, dépliants, etc.)
- Rassembler tout le matériel nécessaire à la causerie pendant la visite
- Prévenir la famille du jour de la visite (négocier un rendez-vous).

2. Que faut-il faire pendant la visite :

- Se rendre dans la famille et s'introduire selon les mœurs et les coutumes du milieu
- Échanger les salutations d'usage
- Se présenter si vous n'êtes pas encore connu dans la famille
- Établir un climat de confiance avec les membres de la famille
- Dire les motifs de la visite
- Laisser la famille expliquer ses soucis/préoccupations
- Rassurer la famille de la confiance de l'entretien
- Expliquer les contenus en relation aux soucis/préoccupations de la famille et compléter / donner des informations justes et claires sur le sujet concerné
- En discussion avec la famille, poser des questions claires et précises pour recueillir les opinions de la famille et donner les informations nécessaires à l'atteinte des buts fixés
- À travers des informations, des exemples concrets, aider la famille à adopter des solutions adaptées aux problèmes qui se posent
- Tout au long de la visite, le visiteur (l'animateur) doit se montrer disponible, attentif, courtois, respectueux, patient, etc. (appliquer toutes les qualités d'un bon animateur)
- Faire des synthèses partielles

À la fin des échanges :

- Faire la synthèse générale de la rencontre en faisant ressortir les conclusions importantes que la famille doit retenir de la discussion.
- Remercier la famille pour sa disponibilité et prendre un autre rendez-vous si nécessaire.

3. Après la visite :

- Ranger le matériel et demander la route
- Remplir la fiche technique d'animation et revoir son plan de travail si nécessaire.

III - LES CONDITIONS POUR RÉUSSIR LES VAD DANS LE CADRE DE LA CGC

- L'identification/la connaissance du problème spécifique
- L'identification précise des personnes concernées par le problème au sein de la famille
- La préparation de la visite telle que décrite à l'étape 1 dans "que faut-il faire avant"
- L'exécution de la visite telle que décrite également dans les conclusions de l'étape 2 dans "que faut-il faire pendant la visite".

ANNEXE 2 : L'ANIMATION DE GROUPE

I-DEFINITION

La causerie éducative est d'abord une technique de communication interpersonnelle. C'est un échange entre un animateur et un groupe cible de personnes, sur un sujet précis. Pendant les discussions, ils échangent des expériences, des informations et des connaissances, ceci dans le but Z d'amener un changement de comportement, d'attitude ou de mentalité.

II - ÉTAPES DE RÉALISATION D'UNE SEANCE DE CAUSERIE ÉDUCATIVE :

Avant la séance :

- Choisir le thème / le sujet
- Choisir le groupe cible
- Fixer les objectifs
- Préparer le contenu (se documenter et réviser le sujet)
- Choisir le lieu
- Fixer le rendez-vous (date et heure)
- Choisir les supports (images, contraceptifs, préservatif, etc.)
- Rassembler tout le matériel nécessaire
- Préparer le lieu de la causerie ou la salle (si c'est approprié).

Pendant la séance (le jour de la causerie) :

- Arriver au moins 1 heure avant l'heure prévue pour la causerie
- Accueillir et installer les participants en demi-cercle
- Faire les salutations d'usage
- Se présenter si nécessaire
- Établir le climat (détendre l'atmosphère)
- Annoncer le sujet et le plan de la causerie
- Poser des questions exploratoires pour recueillir les expériences du public : qui a entendu parler du sujet d'aujourd'hui, qui connaît..... etc., qui a eu l'expérience de etc. qui peut parler un peu de etc.,).
- Présenter la session (résumer fréquemment en faisant des synthèses partielles, demander si l'on a bien compris, maintenir le contact visuel avec l'auditoire, etc....).

A la fin des discussions :

- Évaluer
- Clôturer
- Remercier
- Négocier un autre rendez-vous (si nécessaire)

Après la séance :

- Ranger le matériel
- Séance d'évaluation avec réflexion et feed-back par les collègues
- Remplir la fiche de suivi des activités d'animation

- Revoir son plan de travail si nécessaire.

III - POUR AVOIR UNE BONNE CAUSERIE EDUCATIVE

- L'animateur doit respecter les étapes décrites ci-dessus
- L'animateur doit avoir les qualités d'un bon animateur/facilitateur et les mettre en pratique au cours de la discussion.
- Essayer d'avoir un public pas trop grand (entre 15 et 25 personnes maximum).

IV. LES QUALITES D'UN BON ANIMATEUR

Attitudes

- Accueillant
- Respectueux, poli, courtois
- Attentif aux réactions du public
- Flexible Dynamique
- Créatif
- Bien organisé
- Sensible aux sentiments des autres
- Patient
- Disponible
- Tenue correcte (culturellement acceptable), etc.

Compétences de base en communication

- Maîtrise le sujet
- Sait faire des synthèses
- Adopte un langage simple
- Fait participer l'auditoire
- Écoute attentivement
- Pratique l'écoute active
- Sait reformuler
- Sait observer : beaucoup d'informations peuvent être obtenues à partir de l'observation
- Sait analyser et interpréter
- Sait poser des questions ouvertes
- Suggère des alternatives
- Sait récapituler, etc.....

ANNEXE 3 : UTILISATION DE LA BOÎTE IMAGES

I. Rôle de la boîte à images

Chaque thème traité dans le cadre de la promotion des PFE comprend un lot d'images. Le rôle de ces images est de créer la réflexion autour du sujet, de permettre l'expression du groupe, de faciliter la compréhension et de garantir la mémorisation du message.

La boîte à images est donc un aide-mémoire, c'est un résumé du message à faire passer, c'est un moyen pour éviter la monotonie au cours de l'animation ou pour étayer les propos.

L'utilisation de ces images est donc indispensable au bon déroulement des séances d'animation et de sensibilisation. Pour une action efficace, la démarche suivante est suggérée :

II. Préparation des séances

1. Déterminer les objectifs à atteindre
2. Choisir le sujet d'animation
3. Examiner avec attention chacune des images en se posant les questions suivantes :
 - quelle idée exprime l'image ?
 - l'idée apparaît- elle clairement sur l'image ?
 - si non, faut-il ajouter une explication ?
 - faut-il remplacer l'image par une autre ?
 - l'image correspond-elle à l'objectif à atteindre ?
4. Ranger les images selon l'ordre des idées en rapport avec le sujet, les objectifs et l'auditoire. (Bien que les images soient reliées, l'animateur peut changer l'ordre en fonction de ses besoins pédagogiques)
5. Bien préparer les explications.

III. Animation (présentation des images)

1. Introduire le sujet
2. Placer / tenir les images de façon à être visible par tout le monde (veiller à ne pas se mettre devant l'image quand on parle)
3. Demander à tout le monde de regarder l'image attentivement et donner à chacun la possibilité de bien la voir.
4. Demander aux participants ce qu'ils voient. A leur avis que représentent les images ? les laissez- réfléchir. (Si des mots sont inscrits sur l'image, demander si quelqu'un dans l'auditoire sait lire et lui faire lire)
5. Exposer vos idées selon l'ordre prévu.
6. Poser des questions qui stimulent l'intérêt de l'auditoire (cela permettra de juger de la qualité des explications)
7. Susciter des questions
8. Faire des relances
9. Faire un bref résumé

10. Revenir à l'image à la fin de la discussion. Demander à nouveau aux participants ce qu'ils veulent dire, à leur avis. Demander aux participants de résumer ce qu'ils ont appris pendant la présentation de la boîte à images. Après qu'ils ont décrit ce qu'ils ont appris, vous devez clarifier les points essentiels et souligner de nouveau les aspects les plus importants de la boîte à images.

11. Pour clôturer, répéter le message que chaque image véhicule pour aider les participants à s'en souvenir.

NB. Souvenez-vous du dicton suivant : « Ce que j'entends, je l'oublie ; ce que je vois, je le crois » un bon dessin vaut mieux que mille mots. L'utilisation des aides visuelles, si elle n'est pas bien conduite risque de prolonger le temps, de divertir les participants, voire d'induire des erreurs d'interprétation nuisibles au message.